斜视诊疗指南

2026 指南 · 正面

基本评估

病史、远近视力、儿童睫状肌麻痹验光；眼位/运动及双眼视。先矫屈光、治弱视；急性内斜先排颅内病。

2026 PDF1–4、7–8、19–20

内斜分支

全矫后正位→屈光调节性；残余>10△→部分调节性，治弱视后手术。高AC/A>6:1、视近内斜视度大于视远10△，近附加+1.50～+3.00 DS。

2026 PDF5–7

先天斜视时机

先天内斜：≥+2.00 DS先戴镜观察3～6月，建议24月龄前手术。先天外斜12～18月，不稳可18～24月。

2026 PDF4–5、9–10

间歇外斜

控制好观察；频发、控制恶化、立体视/融合下降考虑手术。基本型差<10△；分开过强/集合不足差≥15△。

2026 PDF9–10

斜视诊疗指南

2026 指南 · 背面

麻痹/限制与红旗

先找病因；多数角度稳定约6月再手术，急性肌断裂/眶嵌顿可早介入。术后严重外转受限+复视警惕滑脱。

2026 PDF7–8、11、13–14

术前与用药

儿童全麻需麻醉/儿科评估；2026指南：抗生素术前3日、每日3～4次，品种/滴数未明确。<12岁通常全麻。

2026 PDF19–21

随访

术后1天、1周、1月、3月、6月；后每6～12个月，至视觉发育成熟。调节性内斜5岁前每6月验光，之后每年。

2026 PDF5–6、21

特殊类型与缺项

A-V、Duane、Brown、TED、重眼/MG等需专病路径，见提取表；无统一手术量/分层评分，不用一张卡覆盖全部手术设计。

2026 PDF9–21

原文摘录；处方前核对。详见提取表与原文缺项。

100%原尺寸 · 双面长边翻转